一页临床路径｜干眼患者睑缘管理

2025 版／2026 刊载 · 条件与下一步按原文整理；诊断细则和特殊分支见提取表

1 所有干眼患者：完成睑缘评估

先结构异常，再后部疾病，最后前部睑缘；分型可并存。优先照相＋腺体红外显影。按发现分别进入 2 、 3 或 4 。

2025 版 /2026 刊 p106–107

结构异常

2 有结构异常 → 结构 / 病因处理

眼睑缺损：积极修补；闭合不全：病因治疗及必要时睑缘缝合 / 融合。可与其他睑缘分型并存，合并者同时按 3/4 处理。

2025 版 /2026 刊 p107 、 109

轻中度 /MGD

4 轻中度 /MGD → 居家基础管理

清洁早晚各 1 次、持续 1 个月以上； MGD 热敷 40~45 ℃ 、每次 10 min 以上、每日至少 1 次、建议 2 周以上。重炎症可冷敷。

2025 版 /2026 刊 p108

3 有感染线索 → 按病原体治疗

急性睑板腺炎 / 葡萄球菌性：抗细菌治疗。螨虫性：除螨每日 2 次、一般 2~3 个月；疗效须同时看症状、体征及虫数。

2025 版 /2026 刊 p107–108

需升级

5 效果不佳 / 依从性差 / 中重度 → 院内

个体化选按摩、深度清洁、 IPL 或脉动；继续居家。联合时先 IPL 后按摩 / 热液脉动；囊肿按摩避开病灶。

2025 版 /2026 刊 p107–109

治疗后

复评

6 复评 → 继续、调整或升级

比较症状、睑缘、腺口及睑酯；除螨不以虫数为唯一终点。无效 MGD 可考虑探通。统一复诊间隔和停治阈值：原文未明确。

2025 版 /2026 刊 p108–109

跨行分支： 1→3 感染分型； 2→6 复评； 4→6 复评

节点内条件优先；未列阈值不补编。完整证据、禁忌与特殊人群见提取表。